

DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA: UMA ABORDAGEM JUNGUIANA

DEPRESSION AND RISK OF SUICIDE IN ADOLESCENCE: A JUNGIAN APPROACH

Juliana Martinez Serrano Guidugli¹

Resumo

O presente estudo tem como objetivo discutir e ampliar a reflexão sobre o sentido dos comportamentos suicidas entre adolescentes com um quadro depressivo. De acordo com a perspectiva junguiana, os comportamentos suicidas na adolescência são formas de comunicação e representam uma urgência por transformação, por uma vida mais autêntica. O amparo simbólico poderá contribuir para ressignificar o sofrimento e para que as experiências primordiais, como a morte, sejam experimentadas simbolicamente, liberando, assim, o fluxo da energia psíquica para o desenvolvimento.

Palavras chave: Adolescência; Depressão; Suicídio; Psicologia Analítica.

Abstract

The present study aims to discuss and to expand the reflection on the meaning of suicidal behaviors amongst teenagers in a depressive condition. According to the Jungian perspective, suicidal behaviors in adolescence are forms of communication and represent an urgency for transformation, for a more authentic life. Symbolic support may contribute to reframe suffering and for primordial experiences, such as death, to be experienced symbolically, thus releasing the flow of psychic energy for development.

Key words: Adolescence; Depression; Suicide; Analytical Psychology.

1 Psicóloga pela PUC-SP, Especialização em Farmacodependências pelo PROAD / UNIFESP e psicoterapeuta com Especialização em Psicoterapia Analítica e Abordagem Corporal pelo Instituto Sedes Sapientiae/SP, email: juliana.guidugli@yahoo.com.br

Introdução

A adolescência representa um marco fundamental para o desenvolvimento que assinala a passagem da infância para a idade adulta. Segundo Kiepenheuer (1990), a puberdade pode ser vista como uma encruzilhada que instaura o começo de grandes transformações. O autor utiliza a metáfora da ponte para caracterizar a fase da adolescência; e o adolescente estaria, então, em um vácuo, desprotegido, entre dois mundos distintos e distantes. Haverá um chamado para novas aventuras e o indivíduo, em um impulso heroico, percorrerá um caminho, cruzará fronteiras, abandonando o universo infantil, confortável e conhecido, afastando-se gradativamente da dependência psicológica dos pais, rumo à construção da própria autonomia e à consolidação de aspectos identitários.

Como em outros momentos de crise, não há como crescer e se desenvolver sem algum grau de sofrimento e sem encarar os sacrifícios que são lançados em cada etapa da vida. Os conflitos entre a natureza e a cultura poderão se intensificar e mecanismos defensivos arcaicos poderão ser acionados diante da sensação de ameaça. De alguma maneira e em determinado grau, o adolescente deverá romper com antigos padrões e se deparar com a morte neste processo de renascimento e de resignificação da vida. Antes de progredir, a energia psíquica poderá regredir, voltando-se para o inconsciente, até que consiga reunir a força necessária para prosseguir em sua trajetória de crescimento. Haverá, portanto, um aumento dos riscos, mas também das oportunidades e do aprendizado para a vida. Sabe-se que os adolescentes costumam passar por provações e que este é um período de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de comportamentos de risco, tais como: uso abusivo de substâncias psicoativas, distúrbios alimentares, sexo desprotegido, direção perigosa, atos infracionais e comportamentos suicidas. E o aumento dos impulsos suicidas nesta faixa etária revela a necessidade de um aprofundamento dos estudos sobre o tema.

O objetivo principal da pesquisa retratada neste artigo é discutir e ampliar a reflexão sobre a depressão e o risco de suicídio na adolescência na atualidade, segundo a abordagem junguiana, buscando compreender o sentido dos comportamentos suicidas entre adolescentes que vivenciam um processo depressivo.

Método

Foi realizado um estudo teórico, com enfoque metodológico qualitativo. Desenvolveu-se uma revisão narrativa da literatura publicada sobre o tema utilizando as seguintes palavras-chave: adolescência, depressão, suicídio e psicologia analítica. Além da psicologia analítica, outras abordagens teórico-científicas foram incluídas no estudo a fim de complementar e ampliar a compreensão sobre o fenômeno.

A adolescência como crise no desenvolvimento

A adolescência destaca-se como faixa etária a partir de 1900, sendo reconhecida como um período de crise. Com o crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial e com o aumento do investimento na formação educacional e profissional, houve um certo prolongamento da juventude e o adiamento de algumas responsabilidades. Desde então, percebe-se nos jovens mais dificuldades em abdicar da proteção e da dependência familiar (LE BRETON, 2017).

A Organização Mundial de Saúde reconhece a adolescência como a etapa que vai dos 10 aos 19 anos de idade (WHO, 2014). Entretanto, considera-se que a delimitação desta etapa de vida é mais complexa, podendo sofrer importantes influências socioculturais. Diferente da puberdade, que está relacionada com as transformações físicas e biológicas, a adolescência engloba também as alterações psicológicas, sociais e culturais.

De acordo com a neurociência, o cérebro adolescente passa por inúmeras reestruturações químicas, estruturais e funcionais que podem ajudar a compreender boa parte dos comportamentos apresentados neste período de vida. É comum que na adolescência os estados e as reações emocionais se sobreponham ao controle das ações e dos impulsos. Isto ocorre em parte porque o crescimento cerebral, assim como na infância, acontece de maneira desigual. O lobo frontal e o córtex pré-frontal, responsáveis pelo raciocínio lógico, planejamento das ações e julgamento, demoram mais a amadurecer. Nesta etapa da vida há uma diminuição da substância cinzenta cortical, resultante do processo de poda neural com a eliminação das sinapses excedentes, e em contrapartida há um aumento da substância branca subcortical, que garante maior efetividade na comunicação entre os neurotransmissores (HERCULANO-HOUZEL, 2005; WILKINSON, 2006). Outro fator a ser destacado no desenvolvimento cerebral na adolescência é que há uma maior propensão ao tédio e à busca por riscos devido à perda de parte dos receptores de dopamina do núcleo acumbente que dificultam a ativação do sistema de recompensa. Sendo assim, os jovens frequentemente precisarão de estímulos mais intensos e imediatos para obtenção de prazer (HERCULANO-HOUZEL, 2005).

As mudanças corporais também são relevantes na puberdade e, como ocorrem de forma rápida, profunda e assimétrica, poderão interferir no processo de despedida do corpo infantil e na assimilação do novo corpo. Em apenas três anos o adolescente deverá ganhar cerca de 20% da estatura final e 50% de seu peso adulto (HERCULANO-HOUZEL, 2005). Tais transformações poderão evocar sentimentos de desorientação, desintegração e fragmentação (FRANKEL, 2005). Alguns jovens poderão reagir defensivamente nesse clima de ansiedade e confusão da entrada na adolescência, principalmente se as experiências iniciais com o corpo da mãe forem problemáticas. Poderão sentir-se enclausurados no corpo materno e desenvolver comportamentos autoagressivos (BOVEN-SIEPEN, 1995).

Portanto, indivíduos que vivenciaram corporalmente traumas em etapas iniciais da infância decorrentes de experiências abusivas, invasivas ou de negligência apresentarão mais dificuldades em se adaptar ao novo corpo (WILKINSON, 2006). E, por este motivo, o trabalho corporal, seja por meio das práticas esportivas ou das técnicas corporais utilizadas em um contexto psicoterapêutico, poderá trazer importantes benefícios e contribuições no desenvolvimento dos adolescentes, possibilitando a ampliação da consciência, favorecendo a integração da autoimagem e a autoaceitação.

Resmini (2004) afirma que, assim como ocorre em outros estágios transitórios da vida, a adolescência pode ser compreendida como um período de crise no desenvolvimento. Além das mudanças físicas, destacadas acima, o jovem poderá experimentar o vazio e a solidão mediante os novos desafios da vida, tais como: o distanciamento dos pais, o envolvimento e a vinculação com o grupo, a vivência da sexualidade, as escolhas profissionais e a revisão dos próprios valores. Entretanto, o autor ressalta aspectos positivos relacionados a esta passagem:

É importante salientar que neste caso a palavra crise não significa necessariamente uma ameaça de catástrofe, mas um ponto decisivo, um momento crucial no qual aumenta tanto a vulnerabilidade quanto o potencial do jovem, e, portanto, pode ser a fonte geradora tanto do desajustamento quanto da maior organização e direcionamento da força do indivíduo (RESMINI, 2004, p.17).

Esta é uma fase frequentemente marcada por oscilações, atitudes intempestivas, impulsivas e desproporcionais. Por mais intensas e conturbadas que sejam, todas as vivências deste período serão importantes no processo de individuação, na constituição da identidade e no desenvolvimento de uma relação mais ajustada do sujeito com o mundo. As múltiplas experiências vividas na juventude poderão ampliar o repertório individual, permitindo que novas habilidades sejam adquiridas, possibilitando um avanço no desenvolvimento. Bovensiepen (1995) comenta que a partir da puberdade, com a retirada da libido dos objetos primários, a energia psíquica ficará livre e flutuante, oscilando entre movimentos de progressão quando se propõe a atender às demandas externas e de regressão quando busca reconectar o indivíduo às próprias necessidades. Frankel (2005) revela que esta turbulência na passagem para a vida adulta desencadeia um estado de fragmentação e deintegração que provoca uma sensação de estar sem lugar, sem referências.

Portanto, segundo a compreensão da psicologia analítica, antes de avançar de forma consistente “para fora”, em um movimento de extroversão, é possível que a energia psíquica entre em uma dinâmica regressiva e defensiva de introversão, voltando-se “para dentro”. Sendo assim, o indivíduo, sentindo-se despreparado e desamparado, poderá recolher-se em seu mundo interno na tentativa do ego de buscar a segurança e restabelecer a ordem. Esta será uma oportunidade para que o jovem aprenda a focar no que é essencial e a reconhecer os recursos internos no enfrentamento das novas aventuras de maneira mais descolada das figuras parentais.

No entanto, sem a proteção dos ritos e o amparo coletivo, o processo de amadurecimento pode ficar ainda mais difícil e solitário. Observa-se que atualmente muitos adolescentes tentam encontrar sozinhos o sentido e os propósitos da vida. Assim, podem se perder em um mundo ilimitado com tantas possibilidades e ficar mais expostos ao clima de ansiedade e incertezas. Le Breton (2017) afirma que não existem mais eventos precisos, socialmente marcados e reconhecidos, para caracterizar a mudança de status no acesso à vida adulta e a sociedade ocidental contemporânea falha ao não oferecer as balizas necessárias para esta passagem. Hollis (1995) ressalta que, sem os ritos de passagem, os jovens podem permanecer em um estágio prolongado de dependência, perdendo a conexão com a terra e seus ritmos que forneciam significado e profundidade nesta jornada. Entretanto, Frankel (2005) destaca que a necessidade arquetípica de iniciação continua existindo e muitos indivíduos assumirão caminhos mais perigosos e autodestrutivos nas tentativas inconscientes de autoiniciação, podendo permanecer aprisionados por mais tempo nessas experiências compulsivas.

Ainda assim, apesar das dificuldades enfrentadas, é conveniente lembrar que a maior parte dos problemas que aparecem na adolescência costuma apresentar boa evolução e pode se resolver sem grandes consequências até a entrada na vida adulta. E, para que isso aconteça, conforme ressalta Bovensiepen (2019), os adolescentes deverão contar com as próprias forças internas, que dependem basicamente das experiências infantis mais remotas.

A regressão da energia psíquica na depressão na adolescência

Apesar de considerarmos a depressão como um fenômeno crescente associado à vida moderna, muitas das características relacionadas atualmente ao transtorno depressivo já apareciam desde a Antiguidade e foram descritas ao longo da história, recebendo outras denominações. Na Grécia Antiga, a melancolia era vista como uma manifestação corporal, resultante do desequilíbrio dos quatro fluidos corporais: fleuma, bile amarela, sangue e bile negra. O indivíduo que sofria com o excesso de bile negra, *melaina chole* em grego, era acometido por um intenso desânimo, pela tristeza e apresentava uma tendência ao suicídio. A partir da Idade Média, a perda da razão passou a ser compreendida como um afastamento do sagrado e uma afronta a Deus. A acedia, traduzida como preguiça, era considerada um pecado e conhecida como a “doença dos monges”, já que frequentemente nos monastérios os indivíduos eram tomados por um estado de desesperança e apatia. No Renascimento, a depressão passou a ser idealizada e a estar associada à profundidade da alma, à genialidade e à nobreza de espírito. A partir do século XX, dois movimentos cresceram no tratamento e na compreensão da depressão: o psicanalítico e o psicobiológico. Gradualmente a abordagem médica, fundamentada na

ciência, foi ganhando destaque na cultura ocidental, tornando-se central no tratamento dos transtornos mentais. Os instrumentos classificatórios foram se desenvolvendo e sendo ampliados com descrições cada vez mais minuciosas dos sintomas. Novas medicações surgiram a fim de eliminar ou aliviar a dor, física ou psíquica, e os primeiros antidepressivos apareceram a partir da década de 1950 como uma aposta para revolucionar o tratamento da depressão (SOLOMON, 2002).

Observa-se que, apesar dos avanços na classificação das doenças e no tratamento, delimitar a patologia ainda é um grande desafio. É importante ressaltar que a depressão é um fenômeno biopsicossocial, multifatorial e complexo, que se manifesta de forma singular em cada indivíduo. E, dessa maneira, tanto o diagnóstico quanto as abordagens terapêuticas devem incluir avaliações criteriosas e diferentes conhecimentos. Ramos (1994) ressalta a necessidade de que haja uma nova síntese, em contraponto à dicotomia Medicina-Psicologia, por meio do resgate de abordagens holísticas e práticas integrativas da saúde, nos reaproximando das culturas mais tradicionais.

Ainda que qualquer tentativa de abarcar a compreensão do sofrimento humano seja sempre insuficiente, é importante distinguir a tristeza da depressão que pode assumir um caráter menos criativo e mais defensivo, interferindo no curso natural do desenvolvimento e até mesmo colocando em risco a vida caso esteja associada aos impulsos suicidas.

Byington (2007) coloca que a tristeza profunda, assim como a mania na outra polaridade, são funções vitais e estruturantes, necessárias no processo de elaboração simbólica. Com alguma frequência, poderá ser ativada em situações que envolvem transformação. A dor tem a capacidade de despertar a nossa atenção, indicando possíveis disfunções no trajeto do desenvolvimento, funcionando como um importante guia no diagnóstico e tratamento. No entanto, destaca que todas as funções estruturantes podem tornar-se defensivas e patológicas quando fixadas e não elaboradas. Na depressão mais disfuncional, como acontece em outros quadros neuróticos, o indivíduo permanecerá aprisionado em um universo confortável e seguro, e apresentará dificuldades em aceitar os apelos da alma para a mudança.

Dito de outra forma, Hollis (1995) afirma que, se por um lado os sintomas neuróticos representam a resistência às mudanças, por outro lado buscam restabelecer a noção de eu que em algum momento se perdeu devido às exigências sociais e culturais. Podem ser compreendidos, portanto, como expressões de um desejo de cura e de reequilíbrio da psique.

Entende-se que a depressão na adolescência é particularmente mais difícil de ser diagnosticada e tratada devido à complexidade dos estados mentais nessa etapa da vida. Conforme descrição anterior, esta é uma fase crucial de reorganização e de reorientação do indivíduo no mundo, que implica naturalmente em muitas instabilidades, que podem ser facilmente confundidas com os sintomas descritos em quadros psiquiátricos especí-

ficos. Entretanto, ainda assim, considera-se que os adolescentes estão mais expostos e propensos ao desenvolvimento de certas patologias.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, metade de todos os transtornos mentais começam aos 14 anos de idade, sendo a depressão uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. Em todo o mundo estima-se que 10% a 20% dos adolescentes vivenciem problemas de saúde mental (WHO, 2019).

Melo, Siebra e Moreira (2017) identificaram variações nas descrições da sintomatologia da depressão na adolescência, segundo revisão da literatura sobre o assunto. Enquanto alguns estudos consideram critérios diagnósticos semelhantes ao caracterizar a depressão na vida adulta e na adolescência, outros apontam diferenças significativas para cada faixa etária. Assumpção Jr. e Kuczynski (2018) ressaltam que as disforias nessa etapa da vida podem aparecer como ansiedade, irritabilidade, tristeza ou ainda como uma combinação desses afetos. Bahls e Bahls (2002) descrevem algumas características fenomenológicas da depressão na adolescência, tais como: humor deprimido; perda de energia; desmotivação e desinteresse; retardo psicomotor; desesperança e/ ou culpa; alterações de sono; isolamento; dificuldade de concentração; irritabilidade e instabilidade; prejuízos no desempenho escolar; baixa autoestima; ideias e tentativas de suicídio; e problemas graves de comportamento, especialmente o uso abusivo de álcool e drogas.

De acordo com a abordagem junguiana, as crises no desenvolvimento costumam mobilizar novos símbolos que podem atuar de forma autônoma em uma dinâmica mais inconsciente com o risco de desenvolvimento de alguma patologia se não forem elaborados e integrados à consciência. Observa-se que alguns adolescentes podem permanecer estacionados por mais tempo no reino materno, sendo necessários impulsos heroicos para libertá-los das poderosas forças inconscientes.

Jung (2011) escreve em *“Símbolos da Transformação”* que será necessário ao jovem o sacrifício da infância e da dependência dos pais para que não permaneça ligado a eles pelo laço do incesto inconsciente, que é prejudicial para o corpo e a alma. Reconhece que, enquanto os mais velhos costumam ter medo da morte, os jovens poderão ter medo da vida. Associa o adoecimento nesta etapa da vida a uma atitude de recusa à transformação, aos sacrifícios e à fixação ao padrão de dependência da infância.

Não se vive por um período excessivamente longo no ambiente infantil, no seio da família, sem certo perigo para a saúde mental. A vida chama o indivíduo para a independência, e quem não atender a este chamado, por comodidade e temor infantis, está ameaçado de neurose. E se esta uma vez se instalou, ela cada vez mais se torna motivo para fugir da luta com a vida e permanecer para sempre na atmosfera infantil moralmente envenenada (JUNG, 2011, § 461).

Ao evitar a aventura para proteger o próprio sistema, a psique do adolescente ficará ainda mais vulnerável às ameaças de desintegração e à invasão de conteúdos inconscientes. As fantasias de morte poderão se intensificar e, em uma atitude desesperada, o

jovem poderá recorrer às saídas de emergência na tentativa de se livrar da dor. Segundo Frankel (2005), o adolescente tentará se proteger de todas as formas, isolando-se, deixando de ter um envolvimento pleno com a vida, evitando conflitos e novos sofrimentos. Porém, ainda assim, o inconsciente atrairá situações que reabrem a ferida em busca de transformação. Araujo e Assumpção Jr. (2018) alertam que aqueles que tiveram passado por isolamentos sensoriais na infância poderão sofrer mais nessa passagem e ficar mais expostos às ideias suicidas e às depressões ansiosas. Bovensiepen (1995) relata que, dependendo da qualidade do relacionamento infantil primordial com a mãe, o *revival* emocional e afetivo que ocorre na adolescência poderá evocar intensa ansiedade e acionar defesas patológicas, criando barreiras ao próprio desenvolvimento. Wilkinson (2019) afirma que, ao remontar na adolescência as cenas traumáticas da infância por negligência ou abuso, o jovem poderá apresentar reações dissociativas e dificuldades no processamento simbólico das vivências emocionais e corporais. E diante disso poderá criar um falso eu adaptativo, no qual o sistema psíquico se fará de morto como última defesa.

Porém, o adolescente deprimido, mesmo parecendo passivo ou frágil, na realidade está profundamente mobilizado e sendo convocado a buscar o sentido maior da vida. Tem como desafios compreender o significado da depressão, o chamado de sua alma, e enfrentar seus maiores fantasmas. E conforme destaca Cassorla (2017, p. 26), mesmo a psique aparentemente morta, “... há sempre uma vida latente, submersa, que poderá emergir a qualquer momento.”

O suicídio como ímpeto de transformação

O desespero introduz a experiência de morte e é, ao mesmo tempo, o requisito para a resurreição. A vida como era antes, o *status quo ante*, morreu quando nasceu o desespero. Há apenas o momento, tal como ele é – o germe do que quer que vá nascer – se pudermos esperar (HILLMAN, 2011, p. 106).

Ao longo da história, especialmente após a Revolução Industrial, o suicídio deixou de ser analisado sob a ótica moral ou religiosa, passando a ser compreendido segundo a ótica científica. A partir do século XVIII estabeleceu-se a relação com alguns transtornos mentais, principalmente com a insanidade e a melancolia. No final do século XIX e início do século XX, Sigmund Freud e a psicanálise consideraram o suicídio como um predomínio do impulso de morte sobre o impulso de vida, do autoerotismo negativo, e uma defesa do ego contra a psicose. Em 1897, Émile Durkheim publicou a obra “*O Suicídio*”, abordando o fenômeno de maneira predominantemente sociológica. Em 1942, Albert Camus em “*O Mito de Sísifo*” aborda o suicídio como a questão filosófica mais relevante e propõe que por mais que se tente eliminar o absurdo, característico da existência humana, ele nunca será resolvido. Entre o final do século XX e início do século XXI, a Saúde

Pública passou a coordenar os estudos e as ações de prevenção de suicídio em uma abordagem multidisciplinar (BERTOLOTE, 2012).

Embora a depressão e o suicídio sejam fenômenos que acompanham a humanidade desde os primórdios, observa-se que na sociedade ocidental pós-moderna, guiada pelo controle, razão, produtividade e onipotência, há uma tendência à negação da morte em suas diferentes manifestações. Kovács (1992) afirma que, com as novas tecnologias e equipamentos para mensurar e prolongar a vida, a morte perdeu seu caráter natural, sendo vista como fracasso, impotência ou imperícia. Mesmo que negada, Hillman (2011) adverte que ela permanece à espreita, atuando no plano inferior, inconsciente e instintivo, perturbando a ordem consciente coletiva. Hollis (1999) também ressalta que, quanto mais tentamos afastar os estados sombrios da alma, mais seremos convidados a mergulhar neste universo a fim de cuidar do que foi negligenciado. E, com isso, os casos de depressão e os comportamentos suicidas despontam de forma preocupante.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio se destaca como um problema de Saúde Pública mundial. Por ano, 800 mil pessoas se suicidam, ocorrendo uma morte por suicídio a cada 40 segundos. É considerada a segunda maior causa de óbitos entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Os números relacionados às tentativas de suicídio são ainda mais altos e preocupantes. Diante da relevância desta problemática, a OMS estabeleceu um imperativo global priorizando a prevenção de suicídio e a redução dos índices em até 10% para o período de 2013 a 2020 (WHO, 2018).

Embora o Brasil seja considerado um país com um baixo coeficiente de mortalidade por suicídio, está entre os dez países que registram os maiores números absolutos. O coeficiente médio encontrado entre 2004 a 2010 foi de 5,7% para cada 100 mil habitantes e vem crescendo nas últimas décadas, especialmente entre o grupo de homens idosos, indígenas e em cidades de pequeno e médio porte populacional. No entanto, há uma subnotificação dos casos de suicídio no país, que inclui apenas as informações declaradas nos atestados de óbitos (BOTEGA, 2014). Em um estudo recente realizado em seis grandes cidades brasileiras, constatou-se um aumento de 24% das taxas de suicídio de adolescentes de 10 a 19 anos, entre 2006 e 2015, principalmente entre homens de 15 a 19 anos (JAEN-VARAS ET AL, 2019). Estes dados justificam a necessidade da ampliação dos estudos nesta área.

O suicídio é um fenômeno complexo e multifacetado, que envolve a interação de fatores biológicos, psicológicos e socioculturais e que, portanto, pode ser abordado por diferentes perspectivas. É importante destacar que nem sempre apresentará uma intencionalidade clara. Poderá ocorrer de forma mais consciente ou mais inconsciente, mais premeditada ou mais impulsiva. Da mesma forma, não deverá necessariamente ser compreendido em um *continuum* que segue em uma escalada que parte da ideação suicida, passando pelas tentativas de suicídio, até chegar ao suicídio consumado.

A OMS associa o comportamento suicida a três fatores: ambivalência, impulsividade e rigidez do pensamento, afeto e ações. Esclarece que o suicídio não deve ser visto como manifestação de uma doença, embora frequentemente sejam observadas correlações entre os comportamentos suicidas e determinados transtornos psiquiátricos, com destaque para a comorbidade entre depressão e o alcoolismo (WHO, 2000).

Conforme denota Hillman (2011), o fenômeno do suicídio é incompreensível; no entanto, algumas reflexões são possíveis e podem ajudar a ampliar o olhar sobre o tema, que ainda é um tabu repleto de preconceitos. Solomon (2002) afirma que, por mais que seja um ato impulsivo e carregado de ambivalências, o suicídio é também uma opção que expressa a falência dos recursos individuais para lidar com uma realidade complexa. Bertolote (2012) define o suicídio como um processo que parte de considerações mais ou menos vagas sobre a morte e o morrer, que podem ou não adquirir mais consistência, evoluir para um ato suicida e um desfecho fatal. Cassorla (2017) identifica a presença de fantasias que rondam a morte, que podem desenhar o suicídio como única saída possível para lidar com um sofrimento insuportável. Fukumitsu (2018) desenvolve a ideia de que os atos suicidas marcados pelo desespero, desamparo e a desesperança, apontam para um processo de descontinuidade do sentido da vida, no qual a morte representará uma tentativa de eliminar a dor.

Segundo a Psicologia Analítica, os comportamentos suicidas podem ser considerados arquetípicos e manifestar o conflito que reflete o desejo por uma nova vida, como se parte do indivíduo precisasse morrer para renascer de forma mais autêntica. Hillman (2011) escreve em *“Suicídio e Alma”* que o impulso para o suicídio deve ser abordado como uma condição natural, uma possibilidade no curso da vida, que expressa a necessidade de transformação profunda e radical na busca da essência e do essencial. Marinho (2018) comenta que, da mesma forma que há uma matriz psíquica para a sobrevivência e a preservação da vida, também existe outra que inclui a possibilidade do autoextermínio e, neste sentido, representa o exercício máximo da arbitrariedade humana. Hassano (2018) ressalta que nem sempre o suicida buscará a morte como um fim, já que muitas vezes projetará fantasias inconscientes que podem ter mais relação com a vida do que com a própria morte.

Especialmente na crise da adolescência, o flerte com a morte e os comportamentos autodestrutivos poderão se intensificar conforme descrito anteriormente e, ainda assim, não necessariamente serão indícios de qualquer condição patológica. No entanto, também não devem ser banalizados como “coisas de adolescentes” para despertar a atenção. Nessa etapa da vida, até mesmo tentativas sem uma clara intenção de morte poderão ser fatais, já que há um controle insuficiente dos impulsos. Além disso, observa-se que as tentativas de suicídio apresentam uma tendência à repetição e, por isso, devem ser sempre acolhidas e tratadas com respeito, atenção e cuidado.

Para Resmini (2004), as tentativas de suicídio na adolescência podem ser compreendidas como formas específicas de atuação, que buscam, em última instância, comunicar algo e atuar na defesa do ego contra as ameaças de desintegração e aniquilação. As atuações na adolescência são recursos arcaicos que ressurgem com força nessa etapa da vida e expressam um conflito que não pôde ser transformado em material simbólico. Por mais que representem um risco e uma barreira ao desenvolvimento individual, poderão também impulsionar o adolescente no enfrentamento de seus desafios, ajudando-o na libertação do mundo protegido da infância.

Jung (2011) adverte que o jovem poderá ficar mais exposto às invasões inconscientes e às atuações dos complexos autônomos se permanecer por muito tempo estacionado na “mãe” e aprisionado no movimento regressivo da libido, em uma dinâmica de dependência. E, nesta situação, haverá um risco maior de ser tomado pelos impulsos suicidas. Hassano (2018, p. 62) reforça que o indivíduo dominado pelo complexo autônomo, como ocorre em algumas depressões patológicas, poderá ficar limitado em um universo em que há pouco controle do ego e nessa condição “o preto se torna tão inflexível e pegajoso feito piche, que o estado da alma é tomado por uma literalidade incontestável”. Hillman (2011) ressalta ainda que os atos suicidas na adolescência podem representar um anseio por uma transformação rápida e um paradigma da independência e da afirmação da individualidade, já que nesta transição para a vida adulta, a vivência do não ser deverá preceder a do ser.

De acordo com esta perspectiva, as fantasias suicidas não deverão ser apenas eliminadas, já que podem ajudar no reequilíbrio da psique e revelar as novas possibilidades de vida. Entretanto, é importante que haja um amparo maior nesta passagem, para que os adolescentes sejam capazes de lidar com as imagens da morte e com os conteúdos inconscientes com alguma segurança. Kiepenheuer (1990) refere que a psicoterapia de adolescentes poderá funcionar como um rito de iniciação, oferecendo o apoio necessário no processo de renascimento simbólico e permitindo que os impulsos de morte passem a se manifestar de forma psicológica e simbólica. Oliveira (2012) sugere que na terapia haja espaço para dialogar intimamente com o personagem que representa a morte— “o assassino interior da psique”—buscando compreender as necessidades da alma para o desenvolvimento e refletir sobre o que na psique precisa morrer ou o que não pode mais viver nos mesmos moldes.

Portanto, o ambiente seguro e protegido da psicoterapia deverá ser capaz de conter e de sustentar qualquer manifestação do mundo interior do paciente. A viagem pelos caminhos regressivos, às vezes longos e tortuosos, deverá ser acompanhada com atenção e cuidado, ajudando o adolescente a se reencontrar e a se reinventar. E o trabalho com os símbolos despertados nessa jornada poderá liberar gradualmente a energia psíquica para a progressão, que passará a se direcionar para as demandas externas de maneira mais consciente e consistente. O trabalho com os sonhos, as técnicas corporais e expres-

sivas podem ser recursos terapêuticos fundamentais nesta faixa etária, dando vazão aos conteúdos inconscientes, auxiliando na simbolização e diminuindo a necessidade das atuações.

Considerações finais

A partir da revisão de literatura sobre a depressão e o risco de suicídio na adolescência foi possível levantar algumas ideias e tecer algumas reflexões sobre o sentido desses comportamentos nesta etapa de vida. De acordo com a abordagem junguiana, muitos casos de depressão na adolescência aparecem como uma condição específica e geralmente transitória pertencente ao “adolescer”. Podem representar uma tendência natural para resgatar o estado de segurança do estágio anterior do desenvolvimento. E, neste sentido, o adolescente poderá voltar-se para o mundo interno até que consiga reunir as forças necessárias para a retomada da progressão.

Entretanto, alguns indivíduos poderão resistir aos chamados para a imersão nos movimentos regressivos na tentativa de preservar a ordem do ego e evitar a ameaça de desintegração diante do contato com as feridas remanescentes de etapas iniciais da infância. O ego poderá ficar fixado, em uma atitude unilateral da consciência, priorizando e se submetendo aos valores externos ligados aos padrões de dependência da infância. E, nesta condição, as fantasias de morte poderão se sobrepor à consciência. Segundo a Psicologia Analítica, isto ocorre quando os complexos autônomos, que refletem a dinâmica das profundezas do inconsciente, começam a governar as atitudes do adolescente. As tentativas de suicídio nessa faixa etária podem ser compreendidas como formas específicas de atuação e, dessa forma, representam a dificuldade na transformação simbólica de experiências emocionais e corporais. Entretanto, ainda assim, são comunicações que expressam um conflito psíquico e que apontam para as necessidades de crescimento. Por isso, torna-se fundamental tentar compreender o significado da crise depressiva e dos impulsos suicidas na adolescência, ajudando o indivíduo no processo de renascimento psíquico e de ressignificação da vida.

Embora com alguma frequência os comportamentos suicidas nesta etapa da vida apareçam relacionados à depressão, tais manifestações também poderão ser encontradas em adolescentes saudáveis ou ainda estar associadas a outros transtornos psiquiátricos. É importante ressaltar que o suicídio na adolescência é um fenômeno complexo, multifacetado e multicausal, que sempre intrigou a humanidade, e que foi discutido de formas distintas ao longo da história. Trata-se, portanto, de um assunto inesgotável, que sempre requer novas contribuições, evitando explicações mais reducionistas.

Referências

- ARAUJO, C. A.; ASSUMPÇÃO JUNIOR., F. B. Resiliência na infância e na adolescência. *In: ASUMPÇÃO JUNIOR, F. B. e KUCZYNSKI, E. (orgs.). Tratado de psiquiatria da infância e adolescência.* 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.
- ASSUMPÇÃO JUNIOR., F. B.; KUCZYNSKI, E. Transtornos do Humor. *In: ASUMPÇÃO JUNIOR, F. B.; KUCZYNSKI, E. (orgs.). Tratado de psiquiatria da infância e adolescência.* 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.
- BAHLS, S. C.; BAHLS, F. R. C. Depressão na adolescência: características clínicas. **Interação em Psicologia.** v.6, p.49–57, 2002. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/psi.v6i1.3193>. Acesso em: 16 mai. 2020.
- BERTOLETE, J. M. **O suicídio e sua prevenção.** São Paulo: Editora Unesp, 2012.
- BOVENSIEPEN, G. Introduction to section 1: jung's contribution to the understanding of adolescence and a review of the literature. *In: SIDOLI, M. e BOVENSIEPEN, G. (eds.). Incest fantasies and self-destructive acts: jungian and post-jungian psychotherapy in adolescence.* Londres: Transaction Publishers, 1995, p. 3-14.
- _____. Adolescência: uma perspectiva desenvolvimentista. *In: STEIN, M (ed.). Psicanálise Junguiana: trabalhando no espírito de C. G. Jung.* Petrópolis: Vozes, 2019, p. 400-416.
- BOTEGA, N. J. Comportamento suicida: epidemiologia. **Psicol. USP**, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 231 – 236, Dec. 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6564D20140004>. Acesso em: 22 mai. 2020.
- BYINGTON, C. A. B. Depressão normal e o futuro da civilização: um estudo da função estruturante da depressão pela psicologia simbólica junguiana. **Junguiana.** n.25, p.7-17, 2007. Disponível em: <http://www.carlosbyington.com.br>.
- CASSORLA, R. M. S. **Suicídio - fatores inconscientes e aspectos socioculturais:** uma introdução. São Paulo: Blucher, 2017.
- FRANKEL, R. **The adolescent psyche.** Essex: Routledge, 2005.
- FUKUMITSU, K. O. Suicídio: do desalojamento do ser ao desertor de si mesmo. **Revista USP**, n.119, p.103-114, 2018. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/151579>. Acesso em: 22 mai. 2020.
- GUIDUGLI J.M.S. **Depressão e o risco de suicídio na adolescência:** uma abordagem junguiana. (Trabalho de Conclusão de Curso). Especialização em Psicoterapia Analítica e Abordagem Corporal. São Paulo: Instituto Sedes Sapientiae, 2019. Disponível em:

https://9fca8785-e680-497d-8c37-f24f03052dd4.filesusr.com/ugd/9498ea_829ee193b2314a5e8d7229a1f354fe94.pdf. Acesso em: 4 jun. 2020.

HASSANO, M. **Suicídio e criatividade**: imagens e experiências da morte na alma. (Monografia). Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. São Paulo, 2018.

HERCULANO-HOUZEL, S. **O cérebro em transformação**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.

HILLMAN, J. **Suicídio e alma**. 4a. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

HOLLIS, J. **A passagem do meio**: da miséria ao significado na meia-idade. São Paulo: Paulus, 1995.

HOLLIS, J. **Os pantanais da alma**: nova vida em lugares sombrios. São Paulo: Paulus, 1999.

JAEN-VARAS, D. et al. The association between adolescent suicide rates and socioeconomic indicators in Brazil: a 10-year retrospective ecological study. **Braz. J. Psychiatry**, v.41, n.5, p.389-395,. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2018-0223>. Acesso em: 24 mai. 2020.

JUNG, C. G. **Símbolos da transformação**. Petrópolis: Vozes, 2011.

KIEPENHEUER, K. **Crossing the bridge**: a junguian approach to adolescence. Illinois: Open Court Publishing Company, 1990.

KÓVACS, M. J. (Org.) **Morte e desenvolvimento humano**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.

LE BRETON, D. **Uma breve história da adolescência**. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2017.

MARINHO, M. **Suicídio**: uma aproximação filosófica e simbólica. (Monografia). Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, São Paulo, 2018.

MELO, A. K.; SIEBRA, A. J.; MOREIRA, V. Depressão em adolescentes: revisão da literatura e o lugar da pesquisa fenomenológica. **Psicol. cienc. prof.** v.37, n.1, p.18-34, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-37030001712014>. Acesso em: 24 mai. 2020.

OLIVEIRA, S. R. de. O suicídio e os apelos da alma: reflexões sobre o suicídio na clínica junguiana com pacientes adolescentes. **Mundo Saúde**, v.36, n.1, p.103- 110, 2012. Disponível em: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/90/15.pdf. Acesso em: 24 mai. 2020.

RAMOS, D. G. **A psique do corpo**: uma compreensão simbólica da doença. São Paulo: Summus, 1994.

RESMINI, E. **Tentativa de suicídio: um prisma para compreensão da adolescência.** São Paulo Revinter, 2004.

SOLOMON, A. **O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão.** Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

WILKINSON, M. The adolescent brain. *In*: WILKINSON, M. **Coming into mind: the mind brain relationship: a jungian clinical perspective.** New York: Routledge, 2006.

WILKINSON, M. Psique e cérebro. *In*: STEIN, M. (org.). **Psicanálise junguiana: trabalhando no espírito de C. G. Jung.** Petrópolis: Vozes, 2019, p.453-464.

WHO – World Health Organization. **Preventing suicide: a research for primary health care workers.** Genebra, 2000. Disponível em: https://www.who.int/mental_health/media/en/59.pdf. Acesso em: 24 mai. 2020.

_____. **Folha informativa – Suicídio. Who-inte.** (on line). Genebra, 2018. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5671:folha-informativa-suicidio&Itemid=839. Acesso em: 24 mai. 2020.

_____. **Health for the world's adolescents: a second chance in the second decade. Who-inte** (on line). Genebra, 2014. Disponível em: <https://apps.who.int/adolescent/second-decade/>. Acesso em: 24 mai. 2020.

_____. **Adolescent mental health. Who-inte.** (on line). Genebra, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>. Acesso em: 24 mai. 2020.

